認定調査票(概況調査)

テスト用架空事例

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年10月　日　(テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要支援1)		
対象者氏名	山下 キヨ (やました きよ)	性別	女
生年月日	昭和19年(1944年)5月12日	年齢	82歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(週1回)。福祉用具・住宅改修の利用なし。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	夫は5年前に他界し独居。長女(55歳)は隣市在住で週1回(土曜)訪問し、まとめ買いと通院の送迎をしている。長男(52歳)は県外在住で年2回帰省、月1回程度電話。
居住環境	築40年の木造2階建て持ち家。寝室・居間・台所・トイレ・浴室は1階で、2階は使っていない。玄関に上がり框(約25cm)、浴室の出入口に段差(約10cm)あり。手すりはなし。最寄りのスーパーまで約800m、バス停まで約500m。
使用している機器等	T字杖(屋外のみ)。
生活歴	農家の生まれ。結婚後は夫と小売店を営み、70歳で閉店。近所の友人とお茶飲みをするのが楽しみで、地区のサロンにも以前は通っていた。
本人・家族の主訴	本人:「膝が痛くて、買い物に行くのが一番つらい。でも、まだ家でひとりでやっていきたい。」 長女:「転んで動けなくなっていないか心配。週1回しか来られないので、見てもらえる人がいると安心。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない)　左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	ない　肩関節　股関節　(膝関節)　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-5 座位保持	(できる)　自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　(何か支えがあればできる)　できない
1-7 歩行	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　(何かにつかまればできる)　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　(何か支えがあればできる)　できない
1-10 洗身	(介助されていない)　一部介助　全介助　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　(一部介助)　全介助
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない))　約1m離れた視力確認表の図が見える　目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない　見えているのか判断不能
1-13 聴力	普通　(普通の声がやっと聞き取れる)　かなり大きな声なら何とか聞き取れる　ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-2 移動	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる)　見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-6 排便	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-8 洗顔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-9 整髪	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-10 上衣の着脱	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-11 ズボン等の着脱	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上)　月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる)　ときどき伝達できる　ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	(できる)　できない
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる)　できない
3-4 短期記憶	(できる)　できない
3-5 自分の名前を言う	(できる)　できない
3-6 今の季節を理解する	(できる)　できない
3-7 場所の理解	(できる)　できない

3-8 徘徊	(ない)　ときどきある　ある
3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない)　ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない)　ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない)　ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	(介助されていない)　一部介助　全介助
5-2 金銭の管理	(介助されていない)　一部介助　全介助
5-3 日常の意思決定	(できる(特別な場合でもできる))　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　(一部介助)　全介助
5-6 簡単な調理	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)　□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置　□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　(J2)　A1　A2　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	(自立)　Ⅰ　Ⅱａ　Ⅱｂ　Ⅲａ　Ⅲｂ　Ⅳ　Ｍ

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-2 両膝とも伸展制限あり(完全には伸びない)。正座はできない。 1-3・1-4 ベッドはなく布団で就寝。布団の脇に置いた座卓につかまって寝返り・起き上がりをしている。 1-6・1-8 立ち上がりと立位保持は、膝に手をつくか家具につかまって行う。調査時も座卓に手をついて立ち上がった。 1-7 室内は家具や壁に手を添えて歩く。屋外はT字杖を使用。10分ほど歩くと膝の痛みで休憩が必要。この1年で屋外での転倒が1回(打撲のみ)。 1-11 手の爪は自分で切る。足の爪は前かがみになると腰と膝が痛むため、長女が週1回切っている。 1-13 普通の声では聞き返しが多く、少し大きめの声でゆっくり話すと聞き取れる。補聴器はなし。
第2群 生活機能	2-2 室内は伝い歩きで自力移動。屋外の移動も杖を使い介助なしで行っている。 2-12 総合事業の通所(週1回)と、長女の送迎による月1回の整形外科受診。
第3群 認知機能	3群の各項目は問題なく回答できた。日付や最近の出来事も正確に話す。
第4群 精神・行動障害	特記すべき行動はない。
第5群 社会生活への適応	5-1 3種類の内服薬を、自分でお薬カレンダーにセットして飲んでいる。飲み忘れはほとんどない。 5-5 近所の商店での少量の買物は自分で行う。米・飲料など重い物と週分の食材は、長女が土曜にまとめ買いをしている。頻度の多い方で一部介助とした。 5-6 簡単な調理は自分で行う。立ち仕事が長くなると膝が痛むため、椅子に座って下ごしらえをしている。
特別な医療	該当なし。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	山下 キヨ　(女・82歳)　医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 変形性膝関節症(両側)	約10年前
2. 骨粗鬆症	約5年前(腰椎圧迫骨折)
3. 高血圧症	約15年前
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	両膝の疼痛が続き、鎮痛薬の内服と湿布で対応中。歩行時の疼痛が強く、屋外の歩行距離が短くなっている。骨粗鬆症は内服治療中で、転倒による骨折の危険が高い。血圧は内服で安定。 投薬:降圧薬1種、鎮痛薬(頓用)、骨粗鬆症治療薬、外用薬(湿布)。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):J2　認知症高齢者の日常生活自立度:自立
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題なし/日常の意思決定:自立/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長148cm・体重52kg/両膝関節の痛み(中)・伸展制限あり/麻痺なし/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:補助があればしている(T字杖)/車いす:用いていない/歩行補助具:屋外で使用
(2)栄養・食生活	食事行為:自立/栄養状態:良好/留意点:塩分控えめ
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	転倒・骨折、移動能力の低下、閉じこもり → 下肢筋力の維持、住環境の整備、外出機会の確保
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	通所リハビリテーション(または介護予防の運動の機会)
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	移動:転倒に注意。膝の痛みが強い時は無理をしない。運動:膝に負担の少ない運動を。
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

独居で、転倒時の発見の遅れが心配。手すりの設置など住環境の整備を勧める。